Resumo de Véspera de Psiquiatria

Nov 9, 2026 · @Luis Augusto Lobão Mendes

Resumo curto das 13 aulas que explica o porquê de cada ponto: em cada tema vem primeiro a lógica do transtorno e depois o que a prova cobra. Quem entende o mecanismo não precisa decorar lista, porque consegue deduzir a resposta. Leitura de cerca de 1 hora.

Aulas 1 e 2. Exame do estado mental

A lógica. Na psiquiatria não há exame laboratorial que dê o diagnóstico, então o EEM (exame do estado mental) funciona como o exame físico do psiquismo: você examina função por função e descreve o que **observa**, não o que o paciente diz sentir. Por isso o EEM descreve o afeto (o que você vê) e não o humor (o que ele relata).

Consciência: primeiro descarte o orgânico. Estar alerta (acordado e respondendo) não é o mesmo que estar lúcido (pensando com clareza). O paciente em delirium está acordado, mas confuso. O delirium é sempre causado por uma doença clínica, como uma infecção urinária no idoso, e por isso é emergência: o tratamento é achar a causa. O que o denuncia é que ele **flutua** (melhor de dia, pior à noite) e **destrói a atenção**. Pelo mesmo raciocínio, desorientação no tempo e no espaço sugere causa orgânica, enquanto não saber quem é sugere quadro psiquiátrico.

Atenção: a regra e as duas exceções. Normalmente quem não sustenta o foco se distrai com tudo, e quem fica preso num tema não se distrai. As exceções seguem a energia do paciente: na depressão grave tudo fica lento (não sustenta nem desloca o foco); na mania tudo acelera (fixa e se distrai ao mesmo tempo).

Memória. Na anterógrada o cérebro não grava o novo, como no Alzheimer inicial; na retrógrada perde o que veio antes do evento, como no TCE (traumatismo cranioencefálico). Na confabulação o paciente preenche um buraco de memória com uma história plausível e acredita nela; não está mentindo.

Pensamento: velocidade, forma e conteúdo. A velocidade acompanha o humor (acelerada na mania, lenta na depressão). A forma mostra o grau de desorganização: na mania há fuga de ideias, que ainda têm ligação entre si; na esquizofrenia a ligação vai se perdendo, do afrouxamento ao descarrilhamento e à desagregação, quando nem o tema se entende. O conteúdo é o tema, como o delírio.

Delírio e alucinação. O delírio é um erro do pensamento: uma certeza que nenhuma prova muda. A ideia sobrevalorada é parecida, mas ainda guarda algum fato real por trás. A alucinação é um erro da percepção: ouvir ou ver sem nada presente. Se o paciente **sabe**

que não é real, é alucinose, que aponta para causa orgânica (abstinência alcoólica, perda visual). Alucinação visual também sugere orgânico, porque nos transtornos psiquiátricos predominam as auditivas.

Vontade. O impulso busca prazer imediato; a compulsão busca aliviar uma ansiedade. Essa diferença reaparece no TOC, nas dependências e nos transtornos alimentares.

Catatonia é a psicomotricidade travada (estupor, posturas mantidas, negativismo, ecos). Precisa ser reconhecida cedo porque traz risco de complicações clínicas.

Aula 3. Depressão

A lógica. A depressão não é só "falta de serotonina". Se fosse, o antidepressivo resolveria tudo em dias, e ele melhora cerca de 60% dos sintomas e demora semanas. O modelo atual junta três ideias: os neurotransmissores caem; o neurônio perde plasticidade porque o estresse crônico eleva o cortisol, que reduz o BDNF (o "adubo" dos neurônios), e o hipocampo atrofia; e a inflamação (citocinas que chegam ao cérebro pelo sangue e pelo nervo vago) piora as duas coisas. Isso explica por que o deprimido tem mais doença cardiovascular e por que, com o cérebro menos plástico, até a psicoterapia rende menos.

O diagnóstico. São 5 sintomas por 2 semanas, e um deles tem de ser humor deprimido ou perda de prazer (anedonia), porque esses são o núcleo; os outros (sono, apetite, energia, culpa, concentração, lentidão, ideia de morte) são consequências. A distimia é a versão mais leve e crônica: 2 anos de tristeza quase contínua. Um luto que paralisa a vida por mais de cerca de 2 semanas deixa de ser esperado e precisa ser investigado.

Por que o ISRS demora 6 a 8 semanas. O ISRS (inibidor seletivo da recaptação de serotonina) aumenta a serotonina na sinapse logo no início, mas o próprio neurônio tem um "freio", os autorreceptores, que percebem o excesso e reduzem a liberação. Só depois de semanas esses autorreceptores se dessensibilizam, o freio cai e o efeito aparece. É também por isso que a ansiedade pode piorar nos primeiros dias: o efeito colateral chega antes do benefício.

Como escolher o remédio. Escolha pelo sintoma que predomina:

- **Muita emoção negativa** (choro, irritabilidade, ansiedade): mais serotonina, ou seja, ISRS. A sertralina é segura na gestação e no cardíaco; a fluoxetina está no SUS e serve para crianças.
- **Pouca energia e falta de vontade:** mais dopamina, como a bupropiona, que ainda ajuda a parar de fumar e não tira a libido.
- **Pouco interesse e má concentração:** mais noradrenalina, como os IRSN (inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina). A venlafaxina só vira dupla acima de cerca de 150 mg; a duloxetina também trata dor crônica.

- **Insônia e pouco apetite:** mirtazapina ou trazodona, que dão sono.

Os efeitos dos ISRS seguem a própria serotonina: disfunção sexual, embotamento emocional, hiponatremia no idoso e risco de sangramento, porque as plaquetas também usam serotonina. Os tricíclicos funcionam, mas mexem em muitos receptores: arritmia, convulsão e confusão no idoso.

Quando não responde. Potencializa-se com antipsicótico ou lítio. Diante de risco iminente de suicídio, usa-se o que age rápido: a **ECT** (eletroconvulsoterapia), que não tem contraindicação absoluta e reduz a ideação suicida em semanas, ou a **escetamina**, que bloqueia o receptor NMDA, dispara glutamato e BDNF e restaura a plasticidade em horas ou dias.

Psicoterapia. A TCC (terapia cognitivo comportamental) corrige a interpretação negativa de si, do mundo e do futuro. A ativação comportamental parte de outra ideia: agir primeiro, porque a motivação vem depois da ação, não antes.

Aulas 4 e 5. Bipolar e comportamento suicida

A lógica do bipolar. O TAB (transtorno afetivo bipolar) é um pêndulo da dopamina: na mania ela sobe e o cérebro compensa aumentando o transportador que a recolhe; quando a mania passa, esse transportador continua alto, a dopamina despenca e vem a depressão. E cada episódio lesa neurônios (excesso de glutamato, inflamação, queda do BDNF), por isso a doença é **neuroprogressiva**. O objetivo do tratamento não é só tirar o paciente da crise, mas **impedir o próximo episódio**.

O diagnóstico depende de encontrar a elevação do humor. Muitos bipolares chegam deprimidos e são tratados como depressão comum (de 12,5% a 30% dos "deprimidos"). Pergunte por energia e sono, não só por humor: o maníaco dorme 3 horas e acorda descansado.

- **Mania:** 7 dias, ou menos se precisar internar, com prejuízo grave ou psicose. **Uma mania na vida basta para TAB tipo I.**
- **Hipomania:** 4 dias, uma mudança percebida pelos outros, mas sem prejuízo grave. Hipomania com depressão é **tipo II**, que tem tentativas de suicídio mais letais.
- **Episódio misto** (corpo sem energia com mente acelerada) e **ciclagem rápida** (4 ou mais episódios por ano) são as formas mais graves e de maior risco de suicídio.
- **Diferenciais:** o borderline muda de humor em horas e por conflito ou medo de abandono; o bipolar, em dias a semanas e muitas vezes sem gatilho. O TDAH é contínuo desde a infância; o TAB vem em episódios.

Por que não dar antidepressivo sozinho. Ele empurra o pêndulo para o outro lado: pode virar mania, estado misto ou ciclagem rápida. Na depressão bipolar usam-se lítio, quetiapina, lamotrigina ou lurasidona.

Lítio, o centro do tratamento. Estabiliza, protege o neurônio e tem efeito antissuicídio comprovado. A janela entre a dose que trata e a que intoxica é estreita, por isso se mede a litemia (na mania, cerca de 1,0 mEq/L), sempre 12 horas após a última dose para medir o vale. Como o rim reabsorve o lítio junto com o sódio, tudo que faz perder sódio ou reduz a filtração **aumenta a litemia**: diuréticos, anti-inflamatórios e IECA. Por agir no rim e na tireoide, monitoram-se creatinina, TSH e cálcio, e urinar demais sugere diabetes insípido.

Os outros estabilizadores. O valproato é bom na mania e nos estados mistos, mas é teratogênico. A lamotrigina trata só a depressão bipolar e sobe devagar para evitar rash grave. **Nunca associe os dois:** o valproato eleva o nível da lamotrigina e o risco de Stevens Johnson.

Suicídio

A lógica. O suicídio cresce em degraus, da ideia passiva de morte ao plano detalhado e à tentativa; quanto mais estruturado o plano, maior o risco. Quase todos têm um transtorno mental (cerca de 90%). A depressão lidera em número absoluto porque é muito comum; o bipolar tem o maior risco por paciente.

O que o médico faz. Perguntar diretamente sobre suicídio **não induz** o ato; é obrigatório. A ambivalência (querer viver e querer parar de sofrer) é a janela para intervir. Os sinais de risco alto são os que fecham essa janela: desesperança, tentativa prévia, plano estruturado, acesso a arma ou pesticida e falta de quem cuide. Homens consumam mais; mulheres tentam mais.

Depois da tentativa: acolher sem julgar, estabilizar e **notificar no SINAN**. A prevenção funciona tirando o meio letal do alcance, porque muitas tentativas são impulsivas: restringir pesticidas e armas e vender remédios em embalagens menores.

Aula 6. Psicoses

A lógica. Quase toda a clínica e o tratamento da psicose se explicam por uma ideia: **a dopamina está alta numa via e baixa em outra.** Drogas que sobem a dopamina (cocaína, anfetamina) produzem delírios e alucinações, e remédios que a bloqueiam os tratam.

Via	O que faz	Na psicose	Quando o remédio bloqueia o D2
Mesolímbica	Recompensa e emoção	Dopamina alta: delírio e alucinação	Melhora os sintomas positivos (o efeito desejado)
Mesocortical	Pensamento e iniciativa	Dopamina baixa: apatia, pobreza afetiva	Piora ainda mais os sintomas negativos
Nigroestriatal	Movimento	Normal	Rigidez, tremor, distonia (extrapiramidais)
Tuberoinfundibular	A dopamina freia a prolactina	Normal	Prolactina alta e galactorreia

Como o remédio não escolhe a via, ele trata uma e prejudica as outras três. Os **antipsicóticos atípicos** também bloqueiam o receptor 5-HT2A; como a serotonina, por esse receptor, freia a dopamina no córtex, bloqueá-lo devolve um pouco de dopamina onde ela faltava. Por isso os atípicos dão menos rigidez e menos prolactina e pioram menos os sintomas negativos. O preço é o ganho de peso e a síndrome metabólica.

Esquizofrenia: ruptura da trajetória de vida. O diagnóstico pede dois sintomas psicóticos (pelo menos um entre delírio, alucinação ou pensamento desorganizado), queda do funcionamento em relação ao próprio paciente antes e 6 meses de doença. O que define o prognóstico são os **sintomas negativos**, porque tiram a autonomia e não melhoram bem com remédio; por isso o paciente não volta a ser quem era mesmo sem delírio. A psicose sem tratamento é tóxica para o cérebro: quanto mais tempo sem tratar e mais cedo o início, pior. Os primeiros 5 anos decidem a evolução. A morte precoce vem do coração (fumo, sedentarismo, remédio) e do suicídio (cerca de 10%).

O tempo separa os quadros: menos de 1 mês é psicótico breve; de 1 a 6 meses, esquizofreniforme; 6 meses ou mais, esquizofrenia. No **transtorno delirante** existe só o delírio, e a pessoa funciona bem fora do tema dele. No **esquizoafetivo** há episódios de humor, mas a psicose também aparece sozinha por pelo menos 2 semanas; se ela só aparece dentro da depressão ou da mania, é transtorno do humor com psicose.

Escolhendo o antipsicótico pela farmacologia:

- **Haloperidol:** bloqueio forte de D2, ótimo para agitação (injetável) e com versão de depósito, mas muito extrapiramidal.
- **Olanzapina:** quase sem extrapiramidal, mas seda e engorda.

- **Quetiapina:** liga-se fraco ao D2. Em dose baixa só pega o receptor de histamina e dá sono; em dose alta vira antipsicótico; no meio tem efeito antidepressivo. Por isso serve ao TAB em todas as fases.
- **Aripiprazol:** agonista parcial; dá cerca de 1/3 do sinal da dopamina, baixando onde há excesso sem zerar. Bom perfil metabólico, mas causa acatisia (inquietação).
- **Clozapina:** a mais eficaz, reservada a quem falhou com 2 antipsicóticos, porque pode zerar os neutrófilos; exige hemograma semanal nas 18 primeiras semanas, quinzenal nas 18 seguintes e depois mensal.

Os dois efeitos graves. A **discinesia tardia** é o movimento involuntário depois de anos de bloqueio D2; troca-se para clozapina para dar descanso ao D2. A **síndrome neuroléptica maligna** é febre, rigidez, confusão e instabilidade de pressão e pulso após dose alta de antipsicótico; é emergência de terapia intensiva.

Aulas 7 e 8. Ansiedade e TOC

A lógica. Medo é a resposta a um perigo presente; ansiedade é a antecipação de um perigo futuro. Na ansiedade patológica a amígdala, o "alarme" do cérebro, dispara demais, e o córtex pré-frontal não consegue desligá-la. O que **mantém** a doença é a esquiva: cada vez que a pessoa evita a situação temida, sente alívio, e o cérebro conclui que o perigo era real. Por isso o tratamento central é a **exposição**: enfrentar aos poucos até o alarme aprender que pode desligar.

Todos os transtornos ansiosos são preocupação; o que muda é o foco:

- **TAG** (transtorno de ansiedade generalizada): preocupação com quase tudo, na maioria dos dias, por 6 meses, com corpo tenso, cansaço, irritabilidade, sono ruim e "branco" na mente.
- **Pânico:** o medo é do próprio ataque. O ataque tem início súbito, pico em minutos e 4 ou mais sintomas físicos (coração disparado, falta de ar, tontura, sensação de morte). Vira transtorno quando o paciente passa 1 mês com medo do próximo ataque ou mudando a vida por causa dele. Como os sintomas imitam infarto, embolia e hipoglicemia, **exclua causa orgânica primeiro**.
- **Agorafobia:** medo de lugares de onde seria difícil sair ou receber ajuda (transporte, multidão, sair sozinho).
- **Ansiedade social:** medo de ser avaliado negativamente.
- **Fobia específica:** medo de um objeto ou situação. Não há remédio específico; trata-se só com exposição. Na fobia de sangue e agulha o paciente pode desmaiar (reação vasovagal), então se expõe deitado.

O tratamento farmacológico também segue a lógica do alarme:

- **ISRS** são a primeira linha, porque reduzem a reatividade do alarme a longo prazo. Começam em dose baixa, porque nas primeiras semanas podem piorar a ansiedade.
- **Benzodiazepínicos** aumentam o efeito do GABA, o freio natural do cérebro: acalmam em minutos. Mas geram tolerância e dependência, e por isso servem só como ponte no início ou como resgate na crise.
- **Pregabalina** reduz a entrada de cálcio no neurônio e, com isso, a liberação de glutamato; age mais rápido que o ISRS, sem dependência relevante.
- **Buspirona** demora semanas e não funciona no pânico.
- Após melhorar, mantenha 6 a 12 meses **sem reduzir a dose**: quem para cedo recaí em metade dos casos.

TOC

A lógica. Todo mundo tem pensamentos intrusivos absurdos; a pessoa com TOC os interpreta como perigosos ou imorais. Surge a ansiedade, e o ritual (lavar, conferir, rezar, contar) a alivia. Esse alívio é **reforço negativo**: o cérebro aprende que o ritual evitou a catástrofe, e daí em diante precisa dele cada vez mais. Tentar não pensar piora, porque suprimir um pensamento o faz voltar mais forte.

Tratamento:

- **Exposição com prevenção de resposta:** expõe-se ao gatilho e **não se faz o ritual**. A ansiedade sobe e depois cai sozinha, e o ciclo se desfaz.
- **ISRS em dose alta**, com resposta só entre 12 e 20 semanas.
- Sem resposta, clomipramina ou um antipsicótico associado, que reduz o excesso de dopamina que também existe no TOC.
- A família não deve se adaptar aos rituais (por exemplo, tirar o sapato para o paciente não se angustiar), porque isso alimenta o ciclo.

A **tricotilomania** e a **escoriação** são parentes do TOC, mas movidas por impulso e hábito, não por obsessão; por isso tratam-se com reversão de hábito (trocar o gesto por outro incompatível). Os **tiques** compartilham com o TOC os mesmos circuitos e o excesso de dopamina, e por isso o TOC tem um especificador "relacionado a tique".

Aulas 9 e 10. Trauma, corpo e dissociação

A lógica do TEPT. O TEPT (transtorno de estresse pós-traumático) é uma memória que não foi processada: ela continua "ativa", fragmentada e carregada de emoção, e por isso volta sem ser chamada (lembranças, pesadelos, flashbacks). O paciente passa a evitar tudo que lembre o trauma, e, como no caso da ansiedade, a esquiva impede o cérebro de reaprender que está seguro. Ao mesmo tempo, o sistema de alarme fica ligado o tempo

todo: sobressalto, hipervigilância, insônia, irritabilidade. O diagnóstico exige um evento grave de verdade (ameaça de morte, lesão grave ou violência sexual) e sintomas de quatro grupos: revivescência, esquiva, humor negativo e hiperexcitação. Se o estressor for menor, o diagnóstico é de transtorno de adaptação.

Tratamento. A primeira escolha é a terapia de exposição prolongada (reviver a memória em segurança até ela perder a força), e o remédio de primeira linha é o ISRS.

Por que não dar benzodiazepínico no primeiro mês. Logo após o trauma, o pico de cortisol ajuda o cérebro a processar a memória. O benzodiazepínico apaga a ansiedade visível, mas não o estresse por baixo dela; sem a resposta emocional, a memória não é elaborada e acaba gravada com mais força no hipocampo, o que aumenta o risco de TEPT. Para pesadelos, usa-se doxazosina, que bloqueia a noradrenalina no sono; para a hiper-reatividade, propranolol.

Os tempos do estresse: no transtorno de adaptação, os sintomas começam em até 3 meses do estressor e somem em até 6 meses depois que ele termina. O luto prolongado exige 12 meses de sofrimento intenso no adulto.

Quando a mente fala pelo corpo

A pergunta-chave é sobre a intenção. Em todos estes quadros o sintoma não tem doença orgânica que o explique. O que os separa é se o paciente produz o sintoma de propósito e se ganha algo concreto com isso:

- **Sintomas somáticos:** o sintoma é real e involuntário, mas o paciente gasta pensamento, ansiedade e tempo demais com ele. Consultas regulares e programadas acalmam mais que pedir exame a cada queixa.
- **Ansiedade de doença:** quase não há sintoma; o problema é o medo de estar doente.
- **Conversivo:** um conflito emocional vira um sintoma neurológico (paralisia, crise que parece epiléptica) que não segue a anatomia. É involuntário, não é fingimento. Para diagnosticar, exame normal não basta: é preciso achar um sinal incompatível com a neurologia. Na crise não epiléptica os olhos ficam fechados, o quadril se move e a crise dura muito; o vídeo EEG confirma.
- **Factício:** inventa ou provoca a doença **de propósito**, mas o único ganho é ser tratado como doente.
- **Simulação:** inventa de propósito **para ganhar algo** (dinheiro, afastamento do trabalho). Não é transtorno mental.

Dissociação é a mente se "desconectando" para não sentir uma dor insuportável. A amnésia dissociativa bloqueia o acesso a uma memória traumática que continua armazenada. Na despersonalização o próprio eu parece estranho, e na desrealização o

mundo parece irreal, mas o paciente **sabe** que a sensação não é real; é isso que a separa da psicose. Antes de fechar qualquer desses diagnósticos, exclua epilepsia, AVC e substâncias.

Aulas 11 a 13. Personalidade, alimentação e dependência

Transtornos de personalidade

A lógica. Todo mundo tem traços de personalidade, e eles se ajustam à situação: o tímido consegue falar quando precisa. Vira transtorno quando o padrão fica **rígido**, aparece em tudo e causa sofrimento, desde o fim da adolescência. Como é o jeito de ser da pessoa, remédio não muda a estrutura; o tratamento principal é a psicoterapia, e o fármaco só alivia sintomas.

O jeito mais fácil de distinguir é perguntar o que cada um busca ou teme:

- **Cluster A, os excêntricos:** o paranoide desconfia de todos; o esquizoide se isola porque não tem interesse por pessoas; o esquizotípico se isola por estranheza e ansiedade e tem pensamento mágico (é parente da esquizofrenia).
- **Cluster B, os dramáticos:** o antissocial quer **vantagem** e não sente remorso; o narcisista quer **admiração**, porque tem autoestima frágil; o histriônico quer **atenção**; o borderline teme **abandono**, e esse medo explica a impulsividade, a automutilação e o vaivém entre idealizar e desvalorizar o outro.
- **Cluster C, os ansiosos:** o evitativo quer vínculo, mas teme a crítica; o dependente teme não conseguir funcionar sem alguém que cuide; o obsessivo compulsivo precisa de controle e perfeição.

No borderline o tratamento com mais evidência é a TCD (terapia comportamental dialética). Benzodiazepínico é contraindicado, porque o paciente tende a usar substâncias para aliviar o sofrimento e o remédio aumenta a impulsividade.

Transtornos alimentares

A lógica da anorexia. O nome engana: a paciente sente fome. O problema é que o cérebro passou a ler a fome como ameaça e a restrição como controle e segurança; comer gera culpa, e não comer gera alívio, o que reforça o ciclo. O núcleo é restrição, medo de engordar e imagem corporal distorcida. A gravidade se mede pelo IMC (17, 16, 15), mas quem era obeso pode estar grave com IMC normal (anorexia atípica).

Por que a realimentação é perigosa. Na desnutrição as células ficam vazias de fósforo, potássio e magnésio. Quando a comida volta, a insulina sobe e empurra esses íons para dentro das células, e eles despencam no sangue. A queda do fósforo causa fraqueza,

insuficiência respiratória e arritmia, por volta do quarto dia. Por isso se começa com pouca caloria (5 a 20 kcal/kg/dia), monitorando eletrólitos e ECG e repondo tiamina.

Bulimia e compulsão. Na bulimia há o ciclo de comer muito com perda de controle e depois compensar (vomitar, usar laxante, jejuar), com peso geralmente normal. Na compulsão alimentar há a perda de controle sem compensação. O vômito tira ácido do estômago e deixa o sangue alcalino; o laxante tira base pelo intestino e deixa o sangue ácido. Em ambos a principal ameaça é a hipocalemia, que causa arritmia.

O tratamento de base é a TCC. Os remédios aprovados são **fluoxetina na bulimia** e **lisdexanfetamina na compulsão**. A **bupropiona é proibida na bulimia**, porque baixa o limiar convulsivo, e o paciente que vomita já tem eletrólitos alterados.

Dependências

A lógica. A dopamina não é o hormônio do prazer; ela marca o que é importante repetir. Quando uma recompensa é maior que o esperado, a dopamina dá um pico e grava o comportamento. A droga produz esse pico de forma artificial e intensa, ensinando ao cérebro que usá-la é prioridade. Com o tempo surge tolerância, a droga dá menos prazer, e o uso passa a servir para evitar o mal-estar da abstinência: o reforço deixa de ser positivo (busca prazer) e vira negativo (foge do sofrimento). Ao mesmo tempo o córtex pré-frontal, que freia impulsos, enfraquece.

O que vicia mais: efeito rápido (via inalatória, como o crack) e meia-vida curta, porque a queda rápida gera fissura logo depois do uso. O adolescente é mais vulnerável porque tem o sistema de recompensa pronto e o freio pré-frontal ainda imaturo.

Diagnóstico e abordagem. São 11 critérios (perda de controle, prejuízo social, uso de risco, tolerância e abstinência): 2 a 3 é leve, 4 a 5 moderado e 6 ou mais grave. O paciente passa por estágios de mudança, da negação à ação, e a recaída faz parte do processo, não é fracasso. A entrevista motivacional não confronta: ajuda o paciente a enxergar a distância entre o que faz e o que valoriza. A redução de danos cuida de quem ainda não consegue parar, sem se opor à abstinência.

Fechamento: as regras que resolvem a maioria das questões

1. **Diante de quadro agudo, flutuante, com alucinação visual ou em idoso, pense primeiro em causa orgânica.** Delirium, ataque de pânico no pronto atendimento, sintoma conversivo e amnésia dissociativa só se fecham depois de excluir doença clínica.
2. **O tempo define o diagnóstico.** Hipomania tem 4 dias, mania 7, depressão 2 semanas. Na psicose, menos de 1 mês é breve, de 1 a 6 meses é esquizofreniforme e 6 meses ou mais é esquizofrenia. TAG, agorafobia e fobia pedem 6 meses; distimia e ciclotimia, 2

anos.

3. **Esquiva e ritual mantêm a doença por reforço negativo.** Isso vale para ansiedade, TOC, TEPT e dependência, e por isso o tratamento comum a todos é expor o paciente sem deixar a fuga, o ritual ou a substância acontecer.
4. **Escolha o antidepressivo pelo sintoma** (serotonina para a emoção negativa, dopamina para a falta de energia, noradrenalina para a falta de interesse) e lembre que ele leva semanas para agir.
5. **No bipolar, previna o próximo episódio:** use lítio ou quetiapina, nunca antidepressivo sozinho, e nunca associe lamotrigina com valproato.
6. **No antipsicótico, pense nas quatro vias:** o bloqueio D2 trata a psicose e explica todos os efeitos colaterais.
7. **Benzodiazepínico é ponte, não tratamento.** Nunca no primeiro mês após um trauma e nunca no borderline.
8. **Sempre pergunte sobre suicídio**, porque perguntar não induz; se houver tentativa, notifique no SINAN.
9. **As proibições que mais caem:** bupropiona na bulimia (convulsão), valproato em mulher fértil sem controle (malformação) e internação de dependente como castigo.
10. **Os únicos aprovados:** fluoxetina na bulimia, lisdexanfetamina na compulsão alimentar, lamotrigina só na depressão bipolar e clozapina na esquizofrenia refratária.

Fonte: Masterclass de Psiquiatria, baseada nas apostilas das Aulas 1 a 13 (Mariana Freitas, turma 79A).